Tilt training (entrenamiento ortostático)

Pasos a seguir en un paciente con síncope vasovagal recurrente

Idea central: la exposición ortostática progresiva y repetida busca “entrenar” la respuesta autonomíca y aumentar la tolerancia a la posición de pie. Se indica en síncope **reflejo** recurrente, tras haber descartado una causa cardiogénica. La principal limitación es la **adherencia** (requiere semanas a meses de práctica diaria).

Paso 1. Seleccionar al paciente

Indicaciones

- Síncope reflejo (vasovagal) recurrente, con clínica típica y, de ser posible, pródromos reconocibles.
- Falta de respuesta a las medidas básicas (hidratación, sal, evitar desencadenantes, maniobras de contrapresión).
- Paciente (y familia) motivado, capaz de sostener una rutina diaria. Es de elección en pacientes jóvenes.

No indicar (o replantear) si hay:

- Síncope de causa cardiogénica no descartada: arritmia, cardiopatía estructural, canalopatía, obstrucción al tracto de salida, HTP.
- Hipotensión ortostática clásica / falla autonómica (el mecanismo y el manejo son distintos).
- Síncope sin pródromos y con trauma grave: valorar otras estrategias antes de entrenar de pie sin supervisión.
- Imposibilidad física de mantener la bipedestación prolongada.

Paso 2. Evaluación y educación previas

- Confirmar el diagnóstico: anamnesis dirigida, ECG de 12 derivaciones, ecocardiograma y estudios complementarios según el caso (Holter, test de inclinación, etc.).
- Explicar el mecanismo del síncope reflejo, su benignidad y el objetivo del entrenamiento.
- Reforzar medidas generales: ingesta hídrica aumentada, sal liberal si no hay contraindicación, evitar bipedestación prolongada con calor, ayuno y deshidratación.
- Enseñar las **maniobras de contrapresión** (cruzar piernas y tensar, apretar puños o handgrip, tensar brazos) y a sentarse o acostarse ante el primer pródromo.
- Acordar metas y el modo de registro (diario de entrenamiento, ver página final).

Paso 3. Fase inicial supervisada (opcional, según recursos)

- **En camilla basculante (tilt table):** inclinación de 60 a 70°, con monitoreo de FC y TA, hasta la aparición de síntomas o hasta un tiempo máximo definido (p. ej. 30-40 min). Se repite en sesiones de forma seriada.
- Si no se dispone de camilla, esta fase puede reemplazarse por una sesión de práctica supervisada contra la pared, en el consultorio.
- Objetivos: verificar la técnica, medir el tiempo basal tolerado y generar confianza en el paciente.
- Tener a mano elementos para tratar un síncope (decúbito, acceso a asistencia).

Paso 4. Fase domiciliaria: técnica de la pared

Es la fase central del tilt training. Se realiza todos los días en el domicilio:

- **Posición:** de pie, con la espalda apoyada contra la pared y los talones a unos 15-20 cm de ella. Pies juntos, sin moverse ni cruzar las piernas.
- **Entorno seguro:** piso con alfombra o superficie blanda, otra persona presente (al menos en las primeras semanas) y sin objetos filosos cerca.
- **Condiciones:** bien hidratado, no en ayunas ni con mucho calor; evitar el momento inmediato posterior a una ducha caliente.
- **Frecuencia:** 1 a 2 sesiones por día, todos los días de la semana.
- **Duración inicial:** el tiempo basal tolerado menos 1-2 minutos, o 5-10 min si no hay medición basal.
- **Progresión:** aumentar unos 5 min por semana si no hubo síncope ni presíncope, hasta llegar a 30-40 min por sesión (en niños y adolescentes suele bastar con 20-30 min).

Esquema orientativo de progresión (ajustar según tolerancia):

Semana	Duración sugerida por sesión	Comentario
1	5 min	Aprender la técnica
2	10 min	Si no hubo síntomas, avanzar
3	15 min	
4	20 min	Meta mínima razonable en pediatría
5	25 min	
6	30 min	
7 a 8	35 a 40 min	Meta habitual en adultos

Los esquemas publicados varían en tiempos y frecuencia; este es un modelo práctico, no un protocolo único.

Paso 5. Qué hacer si aparecen síntomas durante la sesión

Ante el primer pródromo (mareo, visión borrosa, sudor, náuseas, calor):
1. Realizar maniobras de contrapresión unos segundos.
2. Si persisten, **sentarse o acostarse de inmediato** con las piernas elevadas. No intentar “aguantar”.
3. Anotar el tiempo alcanzado y los síntomas en el diario.
4. Repetir la sesión más tarde o al día siguiente con la misma duración, sin aumentar.

Paso 6. Duración y mantenimiento

- Sostener la fase diaria durante unos **2 a 3 meses** como mínimo, o hasta alcanzar la meta de tiempo sin síntomas.
- Luego pasar a mantenimiento: 3 a 4 sesiones por semana, para evitar la pérdida del efecto.
- Si el paciente abandona la práctica o aumentan los episodios, retomar la progresión desde un tiempo menor.

Paso 7. Seguimiento

- Control a las 2-4 semanas (revisar técnica, diario y adherencia) y luego a los 3 y 6 meses.
- Evaluar: número de síncopes y presíncopes, tiempo de bipedestación tolerado y calidad de vida.
- Reevaluar el diagnóstico si hay síncope sin pródromos, con esfuerzo, con palpitaciones o con cambios en el ECG.
- Si hay falla del tratamiento o síncopes graves: considerar otras opciones (por ejemplo, farmacológicas, y en casos muy seleccionados otras terapias).

Nivel de evidencia: consideraciones

La guía ESC 2018 de síncope menciona el entrenamiento ortostático como opción en pacientes jóvenes con síncope vasovagal y pródromos (clase IIb). Los ensayos aleatorizados muestran resultados discordantes y la adherencia a largo plazo es baja, por lo que conviene presentarlo al paciente como una estrategia que requiere esfuerzo sostenido y cuyo beneficio no está garantizado. *Conviene verificar la clase de recomendación en la versión vigente de la guía antes de citarla.*

Diario de entrenamiento ortostático

Para completar por el paciente o su familia y traer a cada control

Fecha	Sesión (1 o 2)	Duración (min)	Síntomas (S/N)	Qué síntomas / observaciones

Recordatorio: ante un pródromo, sentarse o acostarse enseguida. Consultar si hay un síncope con golpe, palpitaciones, dolor de pecho o síncope durante el esfuerzo.